Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
1ª Vara Cível da Comarca de Camaquã

Av. Antonio Duro, 260 - Bairro: Centro - CEP: 96180000 - Fone: (51) 99844846 - Email: frcamaqua1vciv@tjrs.jus.br

TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE Nº 5004899-07.2022.8.21.0007/RS

REQUERENTE: ERVINO JAHNKE

REQUERIDO: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

DESPACHO/DECISÃO

Vistos.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Tutela Provisória de Urgência ajuizada por **ERVINO JAHNKE** em face de **ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.** Em síntese, narra ser portador de **OUTROS TIPOS ESPECIFICADOS DE LINFOMA NÃO HODGKIN (CID10: C85.7) – LINFOMA DO MANTO.** Refere que, em razão de sua enfermidade, necessita fazer uso do medicamento **RITUXIMABE 500mg e RITUXIMABE 100mg, 14 frascos e 28 frascos.**

Houve deferimento da liminar pleiteada, considerando que o medicamento é componente especializado da assistência farmacêutica (RENAME), determinando que o Estado do Rio Grande do Sul fornecesse à medicação ao Autor, conforme decisão lançada no **evento 4, DESPADEC1**.

No **evento 44, CONT1** foi apresentada contestação pelo Estado do Rio Grande do Sul alegando: 1) necessidade de observância das teses fixadas pelos tribunais superiores de caráter vinculante (Tema 793-STF e 126-STJ); 2) que o tratamento deve ser fornecido através de CACON/UNACON.

Houve réplica (**evento 68, RÉPLICA1**).

Sobreveio despacho saneador, fixando a matéria como exclusiva de direito (**evento 73, DESPADEC1**), sendo que as partes não apresentaram impugnação.

Foi proferida sentença julgando procedente a ação, confirmando a tutela provisória deferida (**evento 83, SENT1**).

Em sede de recurso de apelação julgado perante a 22.ª Câmara Cível do TJ/RS (**5004899-07.2022.8.21.0007**), a sentença proferida foi desconstituída.

Os autos foram remetidos à Justiça Federal e, em decorrência de decisão exarada nos autos do agravo de instrumento de n.º 5037189-69.2023.4.04.0000, que tramitou perante o TRF da 4.ª Região (**evento 147, DESPADEC1**)[1], o processo retornou à Justiça Estadual, tramitando regularmente, até então.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Decido.

Conquanto inconteste a legitimidade do Estado do Rio Grande do Sul para figurar no polo passivo da presente ação, de pronto, tenho por alinhar-me ao entendimento exposto no julgamento dos Embargos de Declaração oriundos do Recurso Extraordinário de n.º 855.178 - Tema 793 do STF, publicado em 16/04/2020, especialmente no que se trata da responsabilidade solidária dos entes federativos quanto ao dever de prestar atendimento às questões de saúde, **observando-se a repartição de competências no âmbito do SUS**.

Entendo que esta solidariedade se opera em relação ao cidadão, e não entre os entes públicos.

E interpretar o novo posicionamento sob o prisma do simples reconhecimento do direito de regresso entre os entes públicos não atende ao interesse da segurança jurídica, tampouco da redução da demanda processual.

Ademais, sobreveio recente decisão proferida pelo Exmo. Sr. Ministro Gilmar Mendes no TEMA 1.234[1].

Neste sentido, veja-se o recente julgado proferido pelo Tribunal Pleno do STF, referendando a decisão monocrática acima citada:

> *"O Tribunal, por unanimidade, referendou a decisão proferida em 17.4.2023, no sentido de conceder parcialmente o pedido formulado em tutela provisória incidental neste recurso extraordinário, "**para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros**: (i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir; (ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo*

*vedada, até o julgamento definitivo do **Tema 1234** da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); (iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário". Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual Extraordinária de 18.4.2023 (00h00) a 18.4.2023 (23h59). (Grifei).*

No caso dos autos, a medicação postulada pela parte Autora integra o Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (Grupo 1A), conforme lista da RENAME.

E o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar conflito negativo de competência em relação a medicamento pertencente ao Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, entendendo pela competência da Justiça Federal, assim decidiu[2]:

"Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra a decisão de fls. 37/41, por meio da qual o presente conflito de competência não foi conhecido, mediante a aplicação das Súmulas 150 e 254/STJ.
*Nas razões recursais, alega o recorrente tratar-se, na origem, de "demanda que se pleiteia o fornecimento de medicamentos padronizados pelo Sistema Único de Saúde, constantes da Lista Rename, no **Grupo 1A** (Sirolimus 1mg), motivo pelo qual a demanda deve ser direcionada contra a União e consequente encaminhamento do processo, nos termos do RE 1366243 TPI-Ref /SC (Tema 1234 da Repercussão Geral)" (fl. 52) Sem contrarrazões (fl. 64), vieram os autos conclusos.*
É O RELATÓRIO. PASSO À FUNDAMENTAÇÃO.
Melhor compulsando os autos, em juízo de retratação facultado pelos arts. 1.021, § 2º, do CPC e 259, § 3º, do RISTJ, reconsidero a decisão agravada, passando à nova análise do incidente processual.
Sobre o tema, a Primeira Seção, nos autos dos Conflitos de Competência n. 199.988, 199.995 e 200.339, relator o Ministro Gurgel de Faria, realinhou o seu entendimento sobre a matéria objeto de discussão no presente recurso, ficando vencido este relator.
Na ocasião, decidiu a Primeira Seção dar provimento aos recursos do Estado réu, para conhecer dos conflitos e assentar a competência da Justiça Federal. Prevaleceu, assim, a compreensão segundo a qual devem ser conhecidos os conflitos quando se tratar de demanda cujo pedido se refira a medicamentos padronizados, isto é, incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename), sendo inaplicáveis, nessa hipótese, as teses fixadas no IAC 14.
Nesse viés, concluiu pelo reconhecimento da competência da Justiça Federal para processar e julgar as ações nas quais se busca o fornecimento de medicamento integrante dos Grupos 1A e 1B da Rename.
Do voto do relator para o acórdão no CC 199.988, colhe-se o seguinte excerto:
Oportuno ressaltar que, quando o medicamento está incluído na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), ficam mais simples as definições de responsabilidade de cumprimento e de financiamento, já que a Portaria 1.554/2013 do Ministério da Saúde estabelece regras claras de repartição das responsabilidades entre os gestores, mediante classificação dos medicamentos em grupos:
Art. 3º Os medicamentos que fazem parte das linhas de cuidado para as doenças contempladas neste Componente estão divididos em três grupos conforme características, responsabilidades e formas de organização distintas:
I - Grupo 1: medicamentos sob responsabilidade de financiamento pelo Ministério da Saúde, sendo dividido em:
***a) Grupo 1A: medicamentos com aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde, os quais são fornecidos às Secretarias de Saúde dos Estados e Distrito Federal, sendo delas a responsabilidade pela programação, armazenamento, distribuição e dispensação para tratamento das doenças contempladas no âmbito do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica;** e b) Grupo 1B: medicamentos financiados pelo Ministério da Saúde mediante transferência de recursos financeiros para aquisição pelas Secretarias de Saúde dos Estados e Distrito Federal, sendo delas a responsabilidade pela programação, armazenamento, distribuição e dispensação para tratamento das doenças contempladas no âmbito do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica;*
II - Grupo 2: medicamentos sob responsabilidade das Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal pelo financiamento, aquisição, programação, armazenamento, distribuição e dispensação para tratamento das doenças contempladas no âmbito do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica; e III - Grupo 3: medicamentos sob responsabilidade das Secretarias de Saúde do Distrito Federal e dos Municípios para aquisição, programação, armazenamento, distribuição e dispensação e que está estabelecida em ato normativo específico que regulamenta o Componente Básico da Assistência Farmacêutica.
Art. 4º Os grupos de que trata o art. 3º são definidos de acordo com os seguintes critérios gerais:
I - complexidade do tratamento da doença;
II - garantia da integralidade do tratamento da doença no âmbito da linha de cuidado; e III - manutenção do equilíbrio financeiro entre as esferas de gestão do SUS.
Art. 5º O Grupo 1 é definido de acordo com os seguintes critérios específicos:
I - maior complexidade do tratamento da doença;
II - refratariedade ou intolerância a primeira e/ou a segunda linha de tratamento;
III - medicamentos que representam elevado impacto financeiro para o Componente Especializado da Assistência Farmacêutica; e IV - medicamentos incluídos em ações de desenvolvimento produtivo no complexo industrial da saúde.
Art. 6º O Grupo 2 é definido de acordo com os seguintes critérios específicos:
I - menor complexidade do tratamento da doença em relação ao Grupo 1; e II - refratariedade ou intolerância a primeira linha de tratamento.
(Grifos acrescidos).
*Art. 54. A responsabilidade pela programação, armazenamento e distribuição dos medicamentos dos Grupos 1A e 1B é das Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal, sendo a responsabilidade pela aquisição dos medicamentos do **Grupo 1A** do Ministério da Saúde e dos medicamentos do Grupo 1B das Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal.*
Art. 66. O financiamento para aquisição dos medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica está diretamente relacionado ao Grupo em que os mesmos estão alocados.
[...]
*§ 3º Os medicamentos pertencentes ao Grupo 1 são financiados pelo Ministério da Saúde, sendo que, para o **Grupo 1A**, na forma de aquisição centralizada, e para o Grupo 1B, na forma de transferência de recursos financeiros. (Grifos acrescidos).*
Assim, diante dessas regras, é possível afirmar, no que interessa para o caso em concreto, o seguinte:
*(i) Competência da União: aquisição e distribuição dos medicamentos incluídos no **grupo 1A** do componente especializado e financiamento dos medicamentos incluídos no grupo 1B do componente especializado;*
A propósito, confira-se a ementa do julgado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS E REGISTRADO NA ANVISA. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC 14/STJ). INAPLICABILIDADE. DECISÃO LIMINAR NO RE 1.366.243/SC - TEMA 1.234/STF. OBSERVÂNCIA. INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO. JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA.
1. A Primeira Seção desta Corte de Justiça, com fulcro nos arts. 947 do Código de Processo Civil/2015 e 271-B do RISTJ, afetou os Conflitos de Competência n. 187.276/RS, n. 187.533/SC e n. 188.002/SC à sistemática do incidente de assunção de competência (IAC n. 14), tendo firmado teses jurídicas exclusivamente sobre medicamentos não incluídos nas políticas públicas, mas devidamente registrados na ANVISA.
2. A orientação estabelecida no referido Incidente (IAC 14/STJ) não se aplica à hipótese, visto que a parte autora objetiva o fornecimento de medicação oncológica de alto custo e já padronizada pelo SUS para a patologia que lhe acomete, de modo que se

deve observar a decisão liminar proferida no RE 1.366.243 (Tema de RG 1.234) pelo Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu os parâmetros de atuação do Poder Judiciário, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral.
3. Em relação às demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados, a Suprema Corte decidiu que "a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no sistema único de saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir".
4. Quanto aos processos com sentença prolatada até a decisão liminar do STF (17/04/2023), aquela Corte determinou que os autos devem permanecer "no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução".
5. Considerando que União é a responsável financeira pelo custeio de tratamentos oncológicos e de alto custo e, principalmente, que o medicamento em apreço foi incorporado pelo SUS e não há sentença prolatada na demanda, os autos devem ser remetidos à Justiça Federal, a fim de que se decida a lide como entender de direito, levando em conta a noticia do óbito da parte autora.
6. É certo que compete à justiça federal analisar o interesse da União para justificar o seu ingresso na lide. Contudo, a diretriz prevista nas Súmulas 150 desta Corte deve ser aplicada em consonância com os parâmetros estabelecidos no IAC 14/STJ e na decisão liminar do STF (RE 1.366.243/SC), até que sobrevenha o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, a fim de evitar insegurança jurídica e tratamento desigual aos litigantes.
7. Agravo interno provido para conhecer do conflito e declarar a competência do JUÍZO FEDERAL DA 1ª VARA DE BENTO GONÇALVES - SJ/RS.
(AgInt no CC n. 199.988/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, relator para acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 12/6/2024, DJe de 8/8/2024.)
No caso ora sub judice, encontra-se assentado nos autos da ação subjacente tratar-se de pleito de fornecimento de medicamento do Grupo 1A (fl. 30), o que impõe o reconhecimento da competência da Justiça Federal.
ANTE O EXPOSTO, com fundamento nos arts. 1.021, § 2º, do CPC, 34, XXII, e 259, § 3º, do RISTJ, reconsidero a decisão agravada para, em novo exame da matéria, conhecer do conflito de competência, a fim de declarar competente para processar e julgar a demanda a 1ª Vara Federal de Santa Cruz do Sul, ora suscitada.
Dê-se ciência aos Juízos envolvidos e ao MPF.
Publique-se.
Brasília, 20 de agosto de 2024.
Sérgio Kukina
Relator
(AgInt no CC n. 203.380, Ministro Sérgio Kukina, DJe de 22/08/2024.) grifei.

Em razão disso, por se tratar a medicação pleiteada (**RITUXIMABE**) de medicamento padronizado pelo SUS, pertenlecente ao grupo 1A do RENAME, nos termos do disposto no Tema 1.234, **o direcionamento do cumprimento da obrigação à União Federal é a medida que se impõe**.

Assim sendo, intime-se a parte autora para que promova à regularização do polo passivo da ação, postulando a inclusão da União, na forma do art. 115, parágrafo único, do CPC[2], sob pena de extinção da ação.

Com a emenda da inicial, **remetam-se os autos à Justiça Federal.**

Agendada a intimação eletrônica das partes.

Documento assinado eletronicamente por **RAMIRO BAPTISTA KALIL**, em 09/01/2025, às 16:01:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10070890492v11** e o código CRC **f64782b2**.

---

1. Agravo de Instrumento n.º 5037189-69.2023.4.04.0000/RS: Ao que interessa à solução do presente agravo, se extrai da decisão:(a) nas demandas judiciais envolvendo a dispensação de fármacos e ou tratamentos já padronizados: a composição do polo passivo deve observância à repartição de responsabilidades delimitada pelo Sistema Único de Saúde (mesmo que isso implique em deslocamento de competência), cabendo ao juízo verificar a correta formação do triângulo processual e sem prejuízo do deferimento prévio de tutelas de urgência, se o caso assim exigir; (b) nas ações judiciais relativas à dispensação de medicamentos não incorporados: devem ser processadas e examinadas pelo juízo (Estadual ou Federal) ao qual foram distribuídas pelo postulante, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da repercussão geral, a declinação da competência ou a determinação de inclusão da União no polo passivo; e (c) diante da necessidade de se evitar um cenário de insegurança, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; por outro lado, os processos com sentença prolatada até a data daquela decisão (17/04/2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução. No caso em tela (dispensação de medicamento em processo sentenciado), a regra, portanto, é a de processamento do feito permaneça no Juízo Sentenciante, no caso o Estadual (evento 83, SENT1).Quanto ao argumento relativo à observância dos ditames do Tema/IAC 14 do STJ, esta Corte tem reiteradamente afirmado que sua disciplina não impede que o Juiz Federal acolha sua competência jurisdicional (vide TRF4, AG 5051506-09.2022.4.04.0000, SEXTA TURMA, Relator JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, juntado aos autos em 23/05/2023;TRF4, AG 5039456-48.2022.4.04.0000, NONA TURMA, Relator SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, juntado aos autos em 25/11/2022), o que é ratificado pelo STF, com as restrições decorrentes da decisão acautelatória supracitada. Assim, deve ser reformada a decisão para determinar sejam os autos restituídos ao Juízo Estadual.Descabe, entretanto, atribuir efeito suspensivo ao recurso mas deferir antecipação da tutela recursal para atingir o fim buscado pelo recorrente, motivo pelo qual recebo o pedido de atribuição de pedido suspensivo como pedido de antecipação da tutela recursal.Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal.Comunique-se". ↩
1. Tema 1234 - Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS. ↩
2. AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 203380 - RS (2024/0069357-8) ↩
2. Parágrafo único. Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo. ↩